

E

特発性間質性肺炎，まれな組織学的パターン
idiopathic interstitial pneumonias, rare pathological patterns

到達目標

- acute fibrinous and organizing pneumonia (AFOP) の病理像と関連する疾患を説明できる
- bronchiolocentric patterns of interstitial pneumonia (BPIP) の線維化病変の主座を説明できる

本項目では，2013年に発表された特発性間質性肺炎の国際分類において「まれな組織型の間質性肺炎」に分類された2疾患について解説する。

1

acute fibrinous and organizing pneumonia (AFOP)

病因・病態・疫学

AFOPは，2002年にBeasleyらによって報告された疾患群で，organizing pneumonia (OP) や eosinophilic pneumonia (EP) には該当しないが，急性肺傷害のスペクトラムにある組織型とされている¹⁾。

AFOPは特発性とする報告はあるが，膠原病，過敏性肺炎，慢性好酸球性肺炎，環境，感染症，移植後の拒絶反応，薬物に関連する二次性という報告もあり（表1），まだ臨床および放射線画像検討が十分でない現状では，特徴的な組織像を示す疾患であると理解すべきである¹⁻⁴⁾。

症候・身体所見

急性または亜急性の臨床経過をとることが多く，症状も発熱，咳嗽，呼吸困難，胸痛をきたし，進行性の呼吸不全に至る。血痰を呈する症例も散見される^{1,2)}。

また，胸膜炎やまれであるが気胸を合併することがある。

診断・検査

特徴的なAFOPの画像所見は，両側肺底部の浸潤陰影である。またlobar consolidation, ground glass opacity (GGO), patchy consolidationと報告されており，GGOを伴ったlobar consolidationが多いとされている（図1a, c）。

基本的には，診断のために外科的肺生検が施行されるが，クライオ生検で診断がついた例も認められる²⁾。病変は斑状に分布し，肺胞腔内に著明なフィブリンの析出を認め，しばしば小塊状に沈着（fibrin ball）する（図1b, d）¹⁻³⁾。

フィブリンの析出は，diffuse alveolar damage

（DAD）やOPでも観察されるが，AFOPでは，1標本の平均約50%の肺胞腔内に認められる¹⁾。

AFOPでは硝子膜形成がみられない点がDADとの鑑別点となり，EPとは組織学的類似を認めるが，好酸球は目立たないか，観察されない。

しかしながら肺生検組織にてAFOPを疑う所見をみた際には，DADあるいはOPの一部分像をみている可能性を常に念頭におく必要がある。

治療と予後

臨床経過としては，ステロイド治療や免疫抑制薬に反応したという報告例も認められるが，再発頻度が高く，再発時にはより高用量のステロイドが必要であることも多い⁴⁾。

特に急性の経過をとり，人工呼吸器装着を要した患者は予後不良であったとの報告もあり，迅速な対応が求められる¹⁾。

表1 AFOPに関連した疾患

自己免疫性疾患	強直性脊椎炎 抗リン脂質抗体症候群 抗合成酵素抗体症候群 皮膚筋炎/多発筋炎 Sjögren 症候群 全身性エリテマトーデス 原発性胆汁性胆管炎
薬 剤	abacavir amiodarone bleomycin decitabine everolimus sirolimus zacytidine nivolumab
環境原因	エアロゾル，煙霧質 アスベスト 石炭 埃
感染症	<i>Acinetobacter baumannii</i> <i>Aspergillus fumigatus</i> <i>Chlamydia pneumoniae</i> Cytomegalovirus H1N1 Influenza <i>Haemophilus influenzae</i> <i>Histoplasmosis</i> Human immunodeficiency virus (HIV) <i>Pneumocystis jirovecii</i>
移 植	同種造血幹細胞移植 肺移植

[Arnaud D, et al : Am J Case Rep 18 : 1242, 2017 より改変]